

CUESTIONARIO TARRAGONA de ANSIEDAD para CIEGOS

Rafael Pallero González
Pere Joan Ferrando Piera
Urbano Lorenzo Seva



Cuestionario Tarragona de ansiedad para ciegos

Cuestionario Tarragona de ansiedad para ciegos

Rafael Pallero González
Pere Joan Ferrando Piera
Urbano Lorenzo Seva

**Instrumentos de evaluación psicológica
del ajuste a la discapacidad visual**

ONCE
Organización Nacional de Ciegos Españoles
Madrid, 2006

Cuestionario Tarragona de ansiedad para ciegos

Rafael Pallero González, Pere Joan Ferrando Piera y Urbano Lorenzo Seva

ONCE: Rafael Pallero González, Dirección Administrativa de Tarragona
(rpgo@once.es)

Universidad Rovira i Virgili (Departamento de Psicología): Pere Joan Ferrando Piera
y Urbano Lorenzo Seva

Instrumentos de evaluación psicológica del ajuste a la discapacidad visual

Primera edición, Madrid 2006

© de esta edición: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Dirección General. Dirección General Adjunta de Servicios Sociales. Calle del Prado, 24, 28014 Madrid

© los autores

Diseño de la cubierta: Idearium Creación, S. L.

Coordinación de la edición: Departamento de Recursos Culturales. Dirección de Cultura y Deporte. ONCE. Dirección General

La presente edición ha estado al cuidado de Francisco Javier Martínez Calvo

Obra completa:

ISBN-13: 978-84-484-0163-4

ISBN-10: 84-484-0163-8

Este tomo:

ISBN-13: 978-84-484-0165-8

ISBN-10: 84-484-0165-4

D.L.: M. 40.503-2006

Realización gráfica: IRC, S.L.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro, su inclusión en un sistema informático, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares de los derechos de autor.

Impreso en España - Printed in Spain

Índice

Agradecimientos	7
Presentación	9
Ficha técnica	11
Justificación	13
Aplicaciones	17
Descripción de las variables que mide el cuestionario	19
Fases del diseño del cuestionario	21
Descripción del cuestionario	23
Características psicométricas	25
<i>Dimensionalidad y estructura</i>	25
<i>Fiabilidad y capacidad discriminadora</i>	28
<i>Validez</i>	32
<i>Distribución de las puntuaciones</i>	34
<i>Interpretación</i>	37
<i>Grupos normativos</i>	38
Normas para la administración y corrección del cuestionario	41
<i>Material</i>	41
<i>Instrucciones para el administrador</i>	41
<i>Puntuación y corrección</i>	44
<i>Uso de las tablas normativas</i>	44
Referencias bibliográficas	47
Apéndices	51
Apéndice 1. <i>Comentarios aclaratorios de los ítems</i>	51
Apéndice 2. <i>Tablas normativas</i>	53
Apéndice 3. <i>Cuestionario Tarragona de ansiedad para ciegos (CTAC)</i>	59

Relación de figuras y tablas

Figura 1. Histograma de las distribuciones en la escala <i>Ansiedad cognoscitiva</i> con la distribución normal superpuesta	35
Figura 2. Histograma de las distribuciones en la escala <i>Ansiedad fisiológica</i> con la distribución normal superpuesta	35
Figura 3. Histograma de las distribuciones en la escala <i>Ansiedad total</i> con la distribución normal superpuesta	36
Tabla 1. Patrón factorial en dos factores. Rotación procusteana semiespecificada	27
Tabla 2a. Coeficientes de fidelidad	28
Tabla 2b. Índices de discriminación en cada una de las escalas. Correlaciones ítem-total corregido.	31
Tabla 3. Resultados de la validación de constructo.	33
Tabla 4. Estadísticos descriptivos para las escalas <i>Ansiedad cognoscitiva, fisiológica y total</i>	36
Tabla 5a. Características de los grupos normativos.	38
Tabla 5b. Características de los grupos normativos.	39
Tabla 6. Estimación de centiles para las puntuaciones directas de las escalas <i>Ansiedad cognoscitiva, fisiológica y total</i>	53
Tabla 7. Estimación de centiles normalizados para las puntuaciones directas de las escalas <i>Ansiedad cognoscitiva, fisiológica y total</i>	54
Tabla 8. Conversión de puntuaciones directas a puntuaciones T para las tres escalas	55
Tabla 9. Estimación de centiles para las puntuaciones T de las escalas <i>Ansiedad cognoscitiva, fisiológica y total</i>	57
Tabla 10. Estimación de centiles normalizados para las puntuaciones T de las escalas <i>Ansiedad cognoscitiva, fisiológica y total</i>	58

Agradecimientos

En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y a sus directivos, sin cuyo espíritu de apoyo a la investigación, dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas con ceguera, este trabajo no se habría podido llevar a cabo.

Así mismo, hemos de agradecer a las instituciones a las que pertenecemos, la Universidad Rovira i Virgili y la Dirección Administrativa de la ONCE en Tarragona, su colaboración en las gestiones administrativas.

No obstante, el agradecimiento fundamental se lo debemos a todas aquellas personas que, desinteresadamente, han colaborado en la recogida de los datos:

A los jefes de los Servicios Sociales para Afiliados y directores de centros y unidades de la ONCE, que, en su momento, consideraron que sus centros podían colaborar con nosotros.

A los profesionales de la Psicología y de otras especialidades que incorporaron a su labor cotidiana los diversos protocolos de recogida de datos o nos brindaron su asesoramiento:

Ángel Aguilar, Alicia Moreno, Almudena Cacho, Ana Dávila, Carmen Rodríguez, Celia Ballenato, Feliciano Cabañas, Félix Dorado, Francisco Ceña, Francisco J. Checa, Javier Nespral, José A. Belmonte, José Luis González, Laura Blanco, Luis González, M.^a Ángeles Fernández, Juan José Martínez, M.^a del Rosario Martínez, M.^a José Losada, M.^a Pilar Basterrechea, M.^a Victoria Quílez, Manuel Rastoll, Mar Mínguez, Mariano Vázquez, Mercedes Castillo, Miguel Díaz, Núria Yanguas, Purificación Díaz, Rosario Ledesma, Sagrario Cruz y Soledad Luengo.

A los restantes psicólogos, psicólogas y otros profesionales de la ONCE que nos prestaron su inestimable colaboración.

Así mismo, queremos manifestar nuestro agradecimiento al Servicio Bibliográfico de la ONCE por las facilidades dadas, y al Servicio de Documentación sobre discapacidad visual de la ONCE por su asesoramiento en la búsqueda y selección de bibliografía especializada.

Presentación

El *Cuestionario Tarragona de ansiedad para ciegos* se gesta con el propósito de aproximarse al modo como las personas con ceguera viven su adaptación a la situación posterior a la pérdida de la visión, desde una concepción basada en la psicología de las diferencias individuales. En este sentido, cabe señalar que, aunque existan unos patrones genéricos, un marco de referencia general, cada persona responde de una manera diferente e individual ante situaciones similares. Tal vez los procesos sean los mismos, pero el modo como cada uno reacciona en ellos presenta variaciones que son verificables mediante el empleo de instrumentos de evaluación psicológica contruidos con rigor metodológico.

Existen muy pocos instrumentos que evalúen las variables implicadas en el proceso de ajuste al déficit visual, y los que lo hacen no se han diseñado con ese fin ni se han validado normativamente en población española con ceguera. Para llenar en parte estas lagunas, un grupo de investigación, formado por miembros del Departamento de Educación y Psicología de la Universidad Rovira i Virgili y de la Dirección Administrativa de la ONCE en Tarragona, decidió presentarse a la convocatoria de financiación de proyectos de investigación de la ONCE, obteniendo como resultado la firma de un convenio de colaboración entre el director del Departamento de Servicios Sociales para Afiliados de esa entidad y el rector de la citada universidad. El apoyo firmado no se limitó a lo económico, sino que se concretó en una colaboración permanente, lo que ha permitido acceder a una gran parte de la extensa red de centros de servicios sociales para personas con ceguera con que la ONCE cuenta en España. Esta estrecha colaboración ha fructificado en el *Cuestionario Tarragona de ansiedad para ciegos*, a cuyo manual preceden estas líneas, y en el desarrollo de otros proyectos que tienen como propósito aumentar el acervo de instrumentos de evaluación del proceso de ajuste al déficit visual.

Ficha técnica

Nombre: Cuestionario Tarragona de ansiedad para ciegos (CTAC).

Autores: Rafael Pallero González, Dirección Administrativa de la ONCE en Tarragona; Pere Joan Ferrando Piera y Urbano Lorenzo Seva, Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

Administración: individual, leída al usuario por el psicólogo.

Variables evaluadas: ansiedad específica en situaciones relacionadas con el déficit visual. Formas cognoscitiva y fisiológica.

Tiempo estimado de administración: 20 minutos.

Población de destino: personas mayores de 16 años con agudeza visual igual o inferior a 1/10, según la escala de Wecker, o campo visual reducido a diez grados o menos en el mejor de los ojos y con el uso de correcciones ópticas.

Tipificación: baremos en centiles y en escala T referidos a la población española con la situación visual descrita.

Versión informatizada¹ que permite la anotación de las respuestas y ofrece la corrección automática, la obtención de un perfil gráfico y la comparación entre el tratamiento previo y el postratamiento. Las instrucciones de uso se incluyen en el mismo programa.

¹ Realizada por Francisco Ceña Coro, psicólogo de la Delegación Territorial de la ONCE en Asturias.

Justificación

La valoración que la persona que ha perdido total o parcialmente la visión hace de la situación en que se encuentra (los efectos limitadores del déficit sobre su vida, teniendo en cuenta el contexto, las redes de apoyo informal y las características personales) y de la manera como puede manejarse en esa nueva situación, se suele hacer partiendo de la base de que se trata de una situación sumamente estresante; no en vano, gran parte de los recursos que solía utilizar para lo cotidiano pueden verse ahora invalidados o percibirse como ineficaces. La aplicación de estrategias habituales o nuevas ante situaciones que hay que afrontar desde el déficit visual, y la comprobación de la eficacia de su ejecución, puede llevar a una percepción de ineficacia (*no soy capaz de hacer las cosas, o no las hago igual de bien o de rápido que antes*) que, con frecuencia, y siempre dependiendo de la individualidad de cada persona, puede generar una serie de respuestas emocionales (variaciones del ritmo cardíaco y del ritmo respiratorio, aumento de la sudoración, etc.) y de pensamientos (sentirse impotente o inútil ante determinadas situaciones, tener ideas recurrentes sobre la situación en que la persona se encuentra, etc.) relacionados con la situación limitadora (Lazarus, 2000). Tanto las unas como los otros son formas de ansiedad.

Las situaciones concretas en que una persona con ceguera suele encontrarse pueden originar respuestas de ansiedad, incluso aquellas en que las estrategias desarrolladas para manejarlas instrumentalmente —autónomamente o con ayuda de un profesional— sean las más adecuadas. Las situaciones relacionadas con la orientación y la movilidad independiente (Welsh, 1997) son las que con mayor probabilidad darán lugar a respuestas de esa índole.

La evaluación psicológica de este tipo de respuestas debería permitir diseñar programas de intervención que trataran la ansiedad mejorando la calidad de vida de las personas

con ceguera y facilitando los procesos de aprendizaje de habilidades adaptativas en los que la persona debe afrontar situaciones complejas. Los elevados niveles de ansiedad que se generan ante determinadas situaciones estresantes, como la que estamos refiriendo, afectan negativamente al rendimiento en una amplia variedad de situaciones y tareas (Amelang y Bartussek, 1986; Eysenck, 1985). La menor frecuencia o una intensidad moderada de la sintomatología de ansiedad debería, cuando menos, no interferir en las actividades de procesamiento ni en la ejecución de tareas, lo que permitiría obtener mejores resultados en los aprendizajes. Consideramos, además, que el tratamiento adecuado de las respuestas de ansiedad ante situaciones específicas relacionadas con la ceguera facilitaría el mantenimiento y la generalización de los aprendizajes de las habilidades que permiten reducir las limitaciones que la ceguera provoca. Así mismo, como resulta evidente, la reducción del sufrimiento generado por la ansiedad —en el sentido indicado por Bayés (2001)— permitirá mejorar la calidad de vida de la persona con ceguera. En última instancia, la mejora de la vida de las personas que han perdido la vista, total o parcialmente, es el objetivo que nos fijamos quienes trabajamos, desde la perspectiva de la Psicología o de cualquier otra área, en el ámbito de la ceguera.

Los especialistas de la intervención psicológica con personas que presentan déficit visual (Dodds, 1991; Tobin, 1994; Pallero, 2001) coinciden en subrayar la escasez de instrumentos específicos para la evaluación de variables psicológicas en casos de ceguera, en especial de aquellas relacionadas con las reacciones emocionales ante el déficit y el proceso de adaptación a este. Aunque existen algunos en inglés (McBroom, Shindell y Elston, 1997), la ausencia de instrumentos diseñados o adaptados a la población española es casi absoluta, si bien el interés por la investigación en esta área de la Psicología hace que nos mostremos optimistas respecto al futuro próximo. De entre las herramientas psicológicas aparecidas en los últimos años, debemos destacar la escala Leonhardt (1992) para la evaluación del desarrollo de niños ciegos de 0 a 2 años, un instrumento específico que, aunque surgido en otra área

de la Psicología, se ha desarrollado a partir de la población española y para ella.

Los antecedentes de la evaluación de las variables emocionales de personas con ceguera mediante instrumentos específicos los encontramos en Fitting (1954) y Bauman (1963, 1966). Ambos desarrollaron cuestionarios amplios (de 42 y 170 ítems, respectivamente) que evaluaban diversas áreas; aunque ninguna de ellas se refería específicamente a la ansiedad, la lectura detallada del redactado de los ítems permite observar que se preguntaba sobre ella. Posteriormente, Hardy (1968) diseñó la ASB (*Anxiety Scale for the Blind*), con 78 ítems, una adaptación para personas con ceguera del cuestionario de Taylor (1953).

Ya en la última década del siglo XX, Dodds (1991, 1993, 1996) publicó la *Nottingham Adjustments Scale* (versión española de Pallero, Ferrando, Díaz y Lorenzo, 2002) con una subescala denominada *ansiedad/depresión* de 12 ítems en la versión original. Kef (1999), siguiendo el modelo de Dodds, desarrolló un amplio cuestionario de 138 ítems donde se incluyen algunas preguntas que interrogan sobre la ansiedad.

Aplicaciones

El CTAC está concebido para la evaluación de la ansiedad específica relacionada con las consecuencias limitadoras del déficit visual en personas mayores de 16 años, con agudeza visual igual o inferior a 1/10 (escala de Wecker) o campo visual reducido a diez grados o menos, aunque podría administrarse a personas con mayor visión. No se ofrece ninguna recomendación concreta acerca del tiempo que debe transcurrir entre la pérdida de visión y la administración del CTAC, pues este ha mostrado su capacidad discriminadora en un amplio abanico temporal.

Se recomienda su empleo en la valoración psicológica previa a los programas de rehabilitación y en el diseño de intervenciones en el marco de los programas de ajuste psicosocial al déficit visual. La obtención de puntuaciones diferenciadas para la ansiedad cognoscitiva y la fisiológica (siempre que sea posible y que no se deba optar por la puntuación total) permite disponer de una orientación para la toma de decisiones acerca de las estrategias de intervención psicológica y facilita información útil para otros profesionales que intervienen en los programas destinados a personas con ceguera, en especial a los técnicos de rehabilitación. Siguiendo lo indicado por Miguel y Cano en el manual del ISRA (1997), ante una predominancia cognoscitiva se aconseja el uso de técnicas de autoinstrucción, de reestructuración cognoscitiva o de inoculación del estrés, y ante la predominancia fisiológica, entrenamiento en relajación, desensibilización sistemática y técnicas de biofeedback. Las características de la prueba harán que, en ocasiones, se disponga de una puntuación total; en estos casos, el clínico deberá optar por un enfoque más global.

La prueba ha demostrado su utilidad en la elaboración de informes periciales destinados a valorar el impacto emocional del déficit visual que resulta de accidentes.

Descripción de las variables que mide el cuestionario

Spielberger (1972) define el estado de ansiedad como «sentimientos desagradables, conscientemente percibidos, de tensión y aprehensión, con activación asociada del sistema nervioso autónomo». Liebert y Morris (1967) consideran que tal estado de ansiedad es bidimensional. Una primera dimensión, a la que denominaron *worry* (inquietud, preocupación) y a la que nos referiremos como *ansiedad cognoscitiva*, se define como el interés cognoscitivo acerca de las consecuencias del fracaso (Eysenck, 1985) y puede afectar a la tarea por la presencia de pensamientos y preocupaciones irrelevantes para la acción que se ejecuta. La segunda dimensión, denominada *ansiedad fisiológica o emocionalidad*, se refiere al estado afectivo generado por la activación del balance autónomo y se define a partir de medidas psicométricas, por lo que es importante observar que no se evaluará el balance definido objetivamente (p. ej., los registros psicofisiológicos), sino la percepción subjetiva de dicho balance.

Estas dos dimensiones, *ansiedad cognoscitiva* y *ansiedad fisiológica o emocionalidad*, son las que se toman como base para configurar la prueba.

Fases del diseño del cuestionario

La primera fase de construcción del cuestionario tuvo como principales objetivos establecer la base documental y crear su forma experimental. Con este propósito se consultaron y revisaron diversos cuestionarios de ansiedad y, sobre la base de esa revisión teórica y de la experiencia acumulada por los autores en el campo de la discapacidad visual, se elaboró en 1992 un paquete inicial de 150 ítems, de los que se seleccionaron 104. Para su posterior evaluación se acudió a la valoración de distintos jueces (10 psicólogos de la ONCE, 4 técnicos en rehabilitación licenciados en Psicología y un catedrático de Psicología de la personalidad), a los que se solicitó que valoraran el paquete de reactivos siguiendo unos criterios determinados. De este modo se obtuvo una primera forma de 42 ítems, de los cuales se suponía que 27 evaluaban la ansiedad fisiológica y 17 la cognoscitiva.

En la segunda fase, para verificar sus propiedades psicométricas, esa forma experimental se administró en el Centro de Rehabilitación Básica y Visual de Madrid, el Centro de Rehabilitación de Ciegos Adultos Ignacio Satrústegui, la Unidad de Rehabilitación Básica de Ciegos Adultos de Sevilla, la Delegación Territorial de la ONCE en Barcelona y la Dirección Administrativa de la ONCE en Tarragona. La muestra total fue de 162 personas. De ello resultó un instrumento presumiblemente bidimensional, con una elevada fiabilidad, una buena capacidad discriminadora y una apropiada distribución de las puntuaciones totales.

En la tercera fase se quiso confirmar la dimensionalidad y evaluar la validez del modelo; para ello se aumentó el tamaño de la muestra con la aplicación de la prueba a más centros de la ONCE. De esta fase surgió el formato de 35 ítems que ahora se presenta, 15 de los cuales corresponden a la escala fisiológica y 20 a la cognoscitiva.

Este proceso puso de manifiesto la dificultad de investigar en poblaciones reducidas y muy dispersas desde el punto de vista geográfico. La recogida de datos resultó sumamente compleja y requirió la colaboración de muchos profesionales, como queda reflejado en los agradecimientos. Afortunadamente, se pudo contar con profesionales muy expertos, lo que garantizaba la calidad de los datos recogidos; sin embargo, el hecho de que fueran personas muy ocupadas hacía que la colaboración en la investigación interfiriera en su labor cotidiana. La administración del cuestionario para el cálculo de la dimensionalidad precisaba de una única sesión, lo que permitió obtener 352 cuestionarios. La administración del protocolo destinado al cálculo de la validez comportaba, además de una larga sesión inicial, el seguimiento del caso durante más de tres meses, la recogida de informes de otros profesionales y una sesión final. El número de protocolos recogidos fue de 110.

Para mayor detalle sobre el desarrollo del diseño del cuestionario se puede consultar Ferrando y Pallero (1994), Ferrando, Pallero y Lorenzo (1996) y Pallero, Ferrando y Lorenzo (1998, 1999).

Descripción del cuestionario

El cuestionario está formado por 35 ítems correspondientes a las dos escalas que lo componen. Una de ellas, la de ansiedad fisiológica o emocional, la integran 15 elementos que se identifican con su número correlativo dentro del cuestionario (el correspondiente del 1 al 35), la letra «F» y su número en la escala. La otra es la de ansiedad cognoscitiva o de preocupación, compuesta por 20 ítems identificados con su número correlativo dentro del cuestionario, la letra «C» y el número que le corresponde en la escala.

La mayoría de los ítems constan de dos partes. En la primera de ellas se pide a la persona que evoque en su imaginación una situación (independientemente de si la ha vivido o no) relacionada con su déficit. En la segunda se le pide que evalúe, a partir de un adjetivo sugerido (algunos relacionados con reacciones cognoscitivas, otros con reacciones fisiológicas), el grado de ansiedad que cree que experimentaría si viviese la situación en el momento en que se le administra la prueba. Algunos ítems (6) solo tienen esta segunda parte.

Ejemplos de ítems:

1(C1).- Imagínese que, estando solo/a en casa, se le cae una cuchara al suelo y no la encuentra. ¿En qué medida se siente impotente?

5(F2).- Imagínese la primera vez que sale a la calle sin guía. ¿En qué medida siente latir su corazón?

8(C6).- Imagínese que va a tocar una jarra. ¿En qué medida siente que la puede romper?

11(F4).- ¿En qué medida los ruidos inesperados le dejan sin respiración?

18(C10).- Imagínese que va a realizar una tarea complicada. ¿En qué medida piensa que le va a salir mal?

21(C12).- Imagínese que tiene que dirigirse a una persona desconocida para preguntar una dirección. ¿En qué medida se siente cohibido/a?

35(F15).- Imagínese que realiza solo/a un trayecto a pie. ¿En qué medida cree que llegará sudoroso/a al final del mismo?

Los ítems de las dos escalas se presentan y administran mezclados, siguiendo el orden que se estableció al analizar la estructura del cuestionario.

Características psicométricas

Dimensionalidad y estructura

El CTAC se diseñó para medir dos dimensiones distintas, aunque relacionadas, de ansiedad perturbadora del rendimiento. Antes de analizar sus propiedades psicométricas específicas, era fundamental evaluar si los datos empíricos disponibles apoyaban las hipótesis dimensionales y estructurales en las que se basaba la construcción del cuestionario. Para esta evaluación se utilizaron procedimientos de análisis factorial no restricto. Los datos eran los del grupo de tipificación, el cual se describirá con detalle más adelante ($N = 352$).

La hipótesis de que los ítems del CTAC miden esencialmente dos dimensiones se evaluó poniendo a prueba modelos factoriales de uno a cinco factores y estudiando el ajuste de dichos modelos. Todos los análisis factoriales utilizaron el criterio de máxima verosimilitud. La evaluación del ajuste se basó en diversos índices y procedimientos pertenecientes a las siguientes categorías: *a)* índices de bondad de ajuste inferenciales referidos a la distribución chi-cuadrado, *b)* índices descriptivos de bondad de ajuste, *c)* procedimientos gráficos (el *scree-plot*) y *d)* el procedimiento MAP.

Los resultados obtenidos con todos ellos fueron bastante similares y pueden resumirse como sigue: el modelo con un solo factor mostraba un ajuste casi aceptable; el modelo con dos factores tenía un ajuste ligeramente superior y podía ya considerarse aceptable; a partir de dos factores las mejoras en el ajuste eran mínimas. A la vista de estos resultados, la hipótesis de que los ítems del CTAC miden esencialmente dos dimensiones puede considerarse razonable.

Para evaluar la hipótesis estructural se utilizó un procedimiento de rotación procustea semiespecificada. Se construyó una matriz diana donde los ítems que a priori deben medir la ansiedad cognoscitiva definían uno de los

factores, en tanto que el otro factor venía definido por los ítems que miden la ansiedad fisiológica. La solución rotada era bastante limpia y coincidía esencialmente con la matriz diana propuesta; sin embargo, la correlación estimada entre los factores era bastante alta: $r = 0,71$.

En conjunto, los resultados obtenidos con la técnica del análisis factorial (tabla 1) sugieren que las hipótesis en que se basó la construcción del cuestionario son razonablemente correctas. En efecto, los ítems del CTAC parecen medir esencialmente dos dimensiones. Además, una de las dimensiones está definida principalmente por los ítems diseñados para medir ansiedad cognoscitiva, en tanto que los ítems diseñados para medir ansiedad fisiológica definen el otro factor. Finalmente, las dos dimensiones parecen mostrar una estrecha relación.

La forma más sencilla de puntuar una escala consiste en sumar las puntuaciones obtenidas en aquellos ítems que definen dicha escala. La puntuación resultante se denomina *puntuación directa* y debe entenderse como una estimación del nivel en la dimensión o factor que la escala pretende medir. Por ejemplo, la puntuación directa que un sujeto obtiene en la escala de ansiedad fisiológica es una estimación del nivel de ansiedad fisiológica que tiene ese individuo. Desde una perspectiva aplicada, tiene mucha importancia determinar hasta qué punto la puntuación directa refleja fielmente el nivel en la dimensión que se pretende medir.

Para evaluar esta cuestión se utiliza el denominado *coeficiente de fidelidad*, que es una estimación de la correlación que existe entre la puntuación directa en la escala y la dimensión o factor que la escala pretende medir. Los coeficientes de fidelidad estimados en la muestra de tipificación del CTAC fueron los expresados en la tabla 2a.

Los resultados sugieren que la puntuación directa en cada una de las escalas refleja fielmente los niveles en la dimensión o factor que se pretende medir. Además, la correlación entre las puntuaciones directas en cada una de las

Tabla 1. Patrón factorial en dos factores. Rotación procusteana semiespecificada

Ítems	Factor I	Factor II	Comunalidades
27	0,6667		0,3849
8	0,6420		0,3467
16	0,6119		0,3710
17	0,5962		0,3726
20	0,5944		0,3302
1	0,5510		0,2373
9	0,5353		0,3503
33	0,5259		0,4100
6	0,5115		0,2924
2	0,5089		0,3682
26	0,4880		0,3030
3	0,4728		0,2909
29	0,4508		0,2048
7	0,4381		0,2238
18	0,4364		0,3791
23	0,3839		0,1370
22	0,3589	0,2024	0,2720
34	0,3054	0,2385	0,2526
28	0,3040		0,1480
25	0,2623		0,0730
11	0,2305	0,2066	0,1628
21	0,2146	0,3623	0,2868
5		0,8325	0,4961
4		0,6913	0,4378
35		0,6808	0,4652
24		0,6578	0,3981
15		0,5967	0,5180
32		0,5966	0,2847
31		0,5875	0,3756
13		0,5280	0,3171
30		0,4732	0,1558
12		0,4501	0,3194
10		0,4441	0,4381
19		0,4319	0,2446
14		0,3687	0,3436

Tabla 2a. Coeficientes de fidelidad

Escala	Factor 1 (AC)	Factor 2 (AF)
Ansiedad cognoscitiva C	0,93	0,71
Ansiedad fisiológica F	0,73	0,93

escalas fue de 0,74, una cifra muy similar a la correspondiente a la correlación estimada entre los factores, que fue de 0,71. En conjunto, estos resultados justifican el uso de la puntuación directa para corregir el cuestionario y sugieren que no es preciso buscar sistemas de corrección más complejos. Obsérvese, además, que cada escala mide también, aunque con menor fidelidad, el otro factor. Esto se debe a que las dos dimensiones de ansiedad parecen estar fuertemente relacionadas. A la vista de este segundo resultado, parece correcto obtener, además de las puntuaciones directas en cada escala, una puntuación total que resulte de la suma de todos los ítems del CTAC.

Fiabilidad y capacidad discriminadora

En la teoría de los tests, el concepto de *fiabilidad* se refiere a la precisión con que miden las puntuaciones de un test; es decir, la fiabilidad indica hasta qué punto las puntuaciones del test se encuentran libres de error de medida. El grado de precisión se indica mediante un coeficiente de fiabilidad, que puede tomar valores entre cero y uno. Un coeficiente de fiabilidad de uno indicaría que las puntuaciones se hallan totalmente libres de error de medida.

El coeficiente de fiabilidad puede entenderse de dos maneras: como coeficiente de equivalencia o como coeficiente de estabilidad temporal. Un coeficiente de equivalencia indica hasta qué punto las puntuaciones del test reflejan diferencias individuales en una variable en un momento determinado. Un coeficiente de estabilidad, por su parte, indica hasta qué punto las puntuaciones del test

permanecen estables a lo largo del tiempo. Ambos coeficientes proporcionan información complementaria, por lo que conviene tener información sobre los dos. Sin embargo, la estimación de un coeficiente de estabilidad requiere administrar el cuestionario dos veces con un intervalo de tiempo razonable entre una y otra.

En el grupo de tipificación del CTAC, la fiabilidad de las puntuaciones en las escalas de ansiedad cognoscitiva y de ansiedad fisiológica se estimó mediante el coeficiente alfa de Cronbach (α). Técnicamente, α es un estimador correcto de la fiabilidad cuando los ítems del test son esencialmente tau-equivalentes o paralelos. De no ser así, α es una cota inferior de la fiabilidad; es decir, un valor, por ejemplo, de 0,8 debe interpretarse como que la fiabilidad de las puntuaciones del test es, como mínimo, de 0,8. Esta es la interpretación que debe hacerse en el presente caso, ya que la hipótesis de tau-equivalencia esencial se rechazó en ambas escalas.

En la escala de ansiedad cognoscitiva, formada por 20 ítems, la fiabilidad estimada fue de 0,88 y el intervalo de confianza al 95% fue de 0,86 y 0,90. En la escala de ansiedad fisiológica, integrada por 15 ítems, se obtuvieron idénticos resultados (redondeando el segundo decimal). A pesar de que la estimación es la misma, la escala de ansiedad fisiológica muestra una mayor consistencia interna, ya que las puntuaciones alcanzan la misma fiabilidad con un número menor de ítems. Finalmente, las puntuaciones totales, obtenidas sumando todos los ítems del CTAC, mostraban una fiabilidad estimada en $\alpha = 0,93$, con un intervalo de confianza de 0,92 a 0,94.

Como referencia, se considera, en general, que valores de fiabilidad del orden de 0,7 son suficientes cuando el test se usa en investigación teórica; para aplicaciones colectivas, en cambio, serían más apropiados valores de 0,8 a 0,9; y, finalmente, para la evaluación y el pronóstico individual serían deseables valores cercanos a 0,9. Por otra parte, es bien sabido que muchos tests de personalidad tienen fiabilidades bajas, del orden de 0,7. Teniendo en

cuenta todos estos elementos, los resultados obtenidos pueden considerarse aceptables.

La tabla 2b muestra las correlaciones ítem-total en cada una de las dos escalas. Los valores que se presentan nos informan de la contribución de cada uno de los ítems individuales a la fiabilidad de la escala. Para mayor claridad, los ítems se han ordenado en función de la magnitud de la correlación ítem-total. Cabe destacar que los valores de las correlaciones ítem-total concuerdan bastante bien con las cargas factoriales correspondientes en la tabla 2. Este resultado era esperable, ya que la estructura factorial era bastante clara.

Antes de finalizar la descripción de la fiabilidad, conviene advertir que esta no es una propiedad fija del test, sino de sus puntuaciones, y que, por tanto, depende de las características de la muestra en que se calculó el coeficiente. En nuestro caso, las características relevantes del grupo de tipificación fueron las siguientes: 1) desviación típica de las puntuaciones: 16,66 (ansiedad cognoscitiva) y 11,99 (ansiedad fisiológica); 2) error típico de medida: 7,91 (ansiedad cognoscitiva) y 5,69 (ansiedad fisiológica). Si el cuestionario se administrase a grupos muy distintos, sería conveniente calcular de nuevo la fiabilidad de las puntuaciones o, cuando menos, estimarla mediante el coeficiente de homogeneidad relativa.

La *capacidad discriminadora* de un test alude a la capacidad que tienen en promedio las puntuaciones de dicho test para diferenciar entre dos individuos cualesquiera que responden a él. La importancia de esta característica puede valorarse cuando uno se sitúa en el caso extremo de un test con nula capacidad discriminadora, donde todos los sujetos obtienen la misma puntuación. En el extremo opuesto, una elevada capacidad discriminadora significa que las puntuaciones se distribuyen de forma homogénea en todos los valores posibles. Al haber un gran número de puntuaciones diferentes, es posible evaluar la característica que interesa con mucho más detalle que cuando hay un gran número de puntuaciones similares.

**Tabla 2b. Índices de discriminación en cada una de las escalas.
Correlaciones ítem-total corregido**

Escala AC		Escala AF	
Ítems	Discriminación	Ítems	Discriminación
2	0,573	15	0,670
18	0,563	10	0,610
16	0,561	5	0,608
17	0,557	35	0,604
27	0,539	4	0,593
8	0,533	31	0,581
26	0,527	24	0,568
20	0,519	14	0,553
9	0,515	13	0,542
3	0,511	33	0,528
22	0,510	12	0,520
6	0,509	19	0,519
34	0,509	32	0,487
21	0,499	11	0,400
7	0,458	30	0,373
1	0,433		
29	0,416		
23	0,380		
28	0,345		
25	0,277		

Resumen correlaciones	Media	Mínima	Máxima
AC	0,285	0,008	0,649
AF	0,290	0,000	0,595

La capacidad discriminadora puede evaluarse mediante el coeficiente delta (δ) de Ferguson. Este indicador es el cociente entre el número de diferenciaciones efectivas que hace el test en el grupo de interés y el máximo número que podría realizar en este caso (que va en función del número de sujetos, de ítems y de respuestas posibles para cada ítem). Valores de δ cercanos a 1 indican que las puntuaciones del test se distribuyen de forma casi uniforme entre todos los valores teóricamente posibles. En la muestra de tipificación del CTAC, los valores estimados de δ fueron los siguientes: 0,99 en la escala de ansiedad cognoscitiva, 0,99 en la escala de ansiedad fisiológica y 0,98 en la escala total. En los tres casos, la capacidad discriminadora de las puntuaciones es excelente.

Validez

El término *validez* alude, en general, al grado en que la teoría y la evidencia empírica ofrecen apoyo a la interpretación de las puntuaciones en el test. La evidencia respecto a la interpretación válida de las puntuaciones puede obtenerse a partir de diversas fuentes. En este estudio, en particular, se obtuvo de tres fuentes: a) el contenido del cuestionario; b) la estructura interna de la prueba, y c) las relaciones entre las puntuaciones del cuestionario y otras variables.

Las dos primeras fuentes ya se han comentado: la primera se refiere a la aplicación del criterio de jueces, ya descrito en el apartado *Fases del diseño del cuestionario*; la segunda corresponde al análisis factorial de ítems, descrito en la sección *Dimensionalidad y estructura*. El tercer tipo de evidencia para evaluar la validez del cuestionario se basa en el estudio de las relaciones entre las puntuaciones de la prueba y otras variables que a priori deberían estar relacionadas, según la teoría en que se basa el instrumento. Dado que es la teoría la que guía este estudio, debe especificarse el patrón de relaciones esperadas entre el cuestionario y las variables elegidas. En nuestro caso, las variables seleccionadas fueron las siguientes:

- a) Las puntuaciones en la subescala del estado de ansiedad del STAI de Spielberger, un instrumento creado para la evaluación de la ansiedad y cuyo uso se halla muy extendido en España.
- b) Las puntuaciones en las subescalas de la *Nottingham Adjustment Scale* (NAS) de Dodds et al., en su adaptación española (Pallero, Díaz, Ferrando y Lorenzo, 2002), a la que se incorpora, además, la subescala original de *locus de control*.
- c) Las puntuaciones en una escala de 8 ítems desarrollada para esta investigación y que evalúa la percepción de bienestar teniendo en cuenta cuestiones específicas relacionadas con la aparición del déficit, además de otras generales.

Las hipótesis para la validación pueden resumirse como sigue. En primer lugar, se esperaban correlaciones altas (en valor absoluto) entre las puntuaciones de las escalas del CTAC y la escala de estado de ansiedad del STAI, la subescala *indicadores de ansiedad depresión* de la NAS, la subescala *autoestima* de la NAS, la subescala *actitudes* de la NAS y la subescala *aceptación* de la NAS (validez convergente) y la escala de bienestar (a menor ansiedad, mayor percepción de bienestar). Por otra parte, se esperaba encontrar correlaciones sustancialmente más bajas con respecto a las restantes subescalas de la NAS (validez discriminadora). En la tabla 3 se presentan los resultados de la validación de constructo.

Tabla 3. Resultados de la validación de constructo

	STAI	N1A	N2	N3	N5	N1B	N4	N6	N7	B
CTACT	0,39	0,54	0,42	0,35	0,50	0,39	0,16	0,37	0,28	0,30
CTACC	0,41	0,55	0,42	0,40	0,52	0,38	0,21	0,40	0,31	0,30
CTACF	0,30	0,44	0,33	0,23	0,39	0,33	0,07	0,35	0,20	0,25

CTACT: CTAC total. CTACC: CTAC cognoscitivo. CTACF: CTAC fisiológico.

N1A: NAS, indicadores de ansiedad y depresión. N2: NAS, autoestima.

N3: NAS, actitudes. N5: NAS, aceptación. N1B: NAS, ideación suicida.

N4: NAS, locus de control. N6: NAS, autoeficacia. N7: NAS, estilo atributivo.

B: bienestar subjetivo.

En general, la matriz de correlaciones coincide con el patrón esperado. El signo de los valores de correlación también es el esperado (depende de la dirección en que se puntúan las escalas). Nótese, en particular, la elevada validez convergente con respecto a las subescalas de ansiedad y aceptación de la NAS. La tabla indica también, de forma bastante clara, que las escalas del CTAC poseen validez diferencial. Obsérvese, además, que los coeficientes de validez obtenidos con la escala de ansiedad cognoscitiva son consistentemente más elevados que los obtenidos con la escala de ansiedad fisiológica. Este es un argumento a favor del mantenimiento de la distinción entre las dos escalas, ya que, pese a que las puntuaciones tienen la misma fiabilidad, una de ellas muestra correlaciones consistentemente más altas.

Distribución de las puntuaciones

Los resultados que se presentan a continuación se basan en la muestra total de estandarización (352 participantes). Se analizan las puntuaciones en las escalas de ansiedad cognoscitiva, ansiedad fisiológica y ansiedad total.

Los histogramas de las tres escalas se presentan en las figuras 1, 2 y 3, y se imprimen con la distribución normal teórica superpuesta. Como se puede apreciar, las puntuaciones se ajustan adecuadamente a los límites de la escala. Por otra parte, la mayor parte de las puntuaciones se agrupan en torno a los valores centrales de la escala.

La tabla 4 muestra la media, la desviación típica, la varianza, el sesgo y la curtosis. Así mismo, incluye una prueba para determinar si las distribuciones de las puntuaciones difieren significativamente de una distribución normal. Como ya apuntábamos, las medias de las tres escalas coinciden con las puntuaciones centrales. Finalmente, las distribuciones de las puntuaciones no se apartan significativamente ($\alpha = 0,05$) de una distribución teórica normal.

Figura 1. Histograma de las distribuciones en la escala *Ansiedad cognoscitiva* con la distribución normal superpuesta

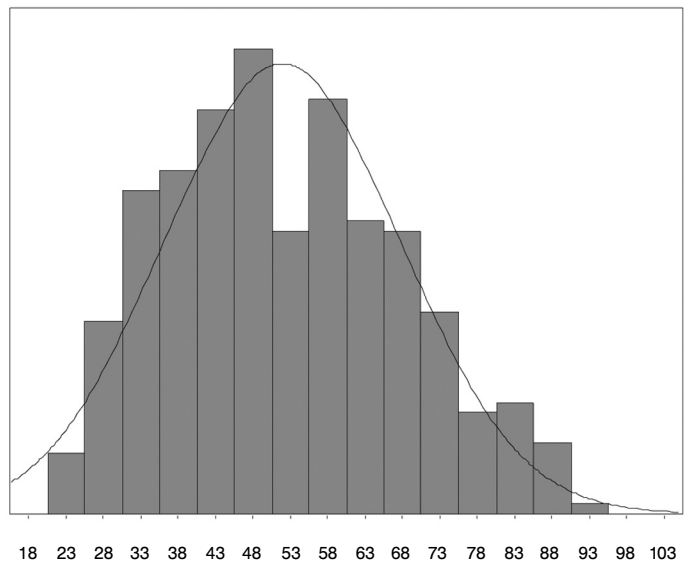


Figura 2. Histograma de las distribuciones en la escala *Ansiedad fisiológica* con la distribución normal superpuesta

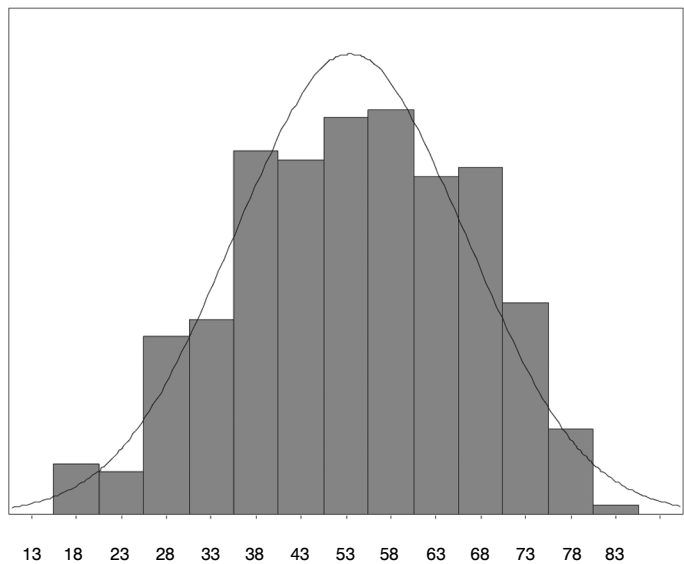


Figura 3. Histograma de las distribuciones en la escala *Ansiedad total* con la distribución normal superpuesta

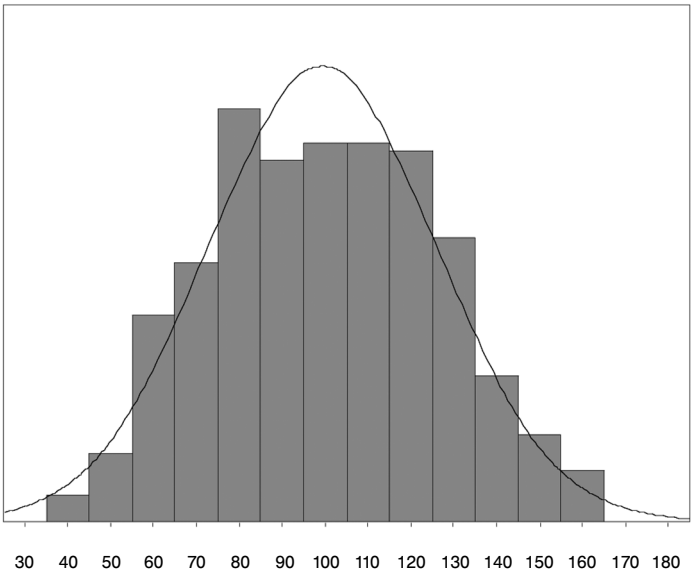


Tabla 4. Estadísticos descriptivos para las escalas *Ansiedad cognoscitiva*, *fisiológica* y *total*

Estadístico descriptivo	Ansiedad cognoscitiva	Ansiedad fisiológica	Ansiedad total
Media	51,45	47,95	99,4
Desviación típica	15,75	12,85	26,48
Varianza	248,12	165,03	700,93
Sesgo	0,31	-0,18	0,07
Curtosis	-0,61	-0,71	-0,59
Z de Kolmogorov-Smirnov	1,21	1,24	0,97
Significación asintótica (bilateral)	0,11	0,09	0,3

Interpretación

La pertenencia a las distintas áreas delimitadas por los centiles nos permitirá establecer la intensidad de los niveles de ansiedad; así, podremos diferenciar entre presencia mínima de ansiedad (por debajo del centil 25), ansiedad leve (entre 25 y 50), ansiedad moderada (entre 50 y 80) y ansiedad grave (por encima del 80). Se deberá prestar especial atención, por su severidad, a aquellos casos en que el centil resultante se sitúe en la mitad superior del último decil. La decisión del uso de las puntuaciones de las escalas por separado o de la escala total, especialmente para establecer criterios de intervención, dependerá de que, una vez convertidas a centiles las puntuaciones directas de las escalas, haya una diferencia mínima de un decil. En caso contrario, no se podrá indicar que exista un predominio de una de las formas de ansiedad sobre la otra, y se usará la puntuación total, lo que permitirá evitar posibles errores de medida.

Ejemplo. En la corrección de las puntuaciones se obtienen los siguientes valores:

	Puntuaciones directas	Centiles	Puntuaciones T
Subescala cognoscitiva (C)	54	60	52
Subescala fisiológica (F)	55	75	55
Escala total (C + F)	109	65	54

En este caso, nos decantaríamos por utilizar las puntuaciones de las escalas por separado, al existir entre ellas una diferencia de más de un decil. Ambas serían moderadas. Incidiríamos más en un enfoque sobre la sintomatología fisiológica, si bien, en este caso, al no ser la diferencia muy acusada, se considerarían también algunas estrategias terapéuticas orientadas a lo cognoscitivo.

El análisis cualitativo de los ítems del CTAC aportará información útil para las intervenciones terapéuticas, pues indicará qué situaciones actúan con mayor intensidad como generadoras de estrés.

Grupos normativos

En las tablas 5a y 5b se recogen las características de los grupos usados para la estandarización del cuestionario. Tal y como se explicó anteriormente, la diferencia en el tamaño de los grupos responde a las dificultades que representa la investigación en grupos reducidos y dispersos.

Tabla 5a. Características de los grupos normativos

	T	H	M	R	M	dt	ct	cp	dvs	dvm
A	352	192	160	15-87	45,6	16,6	173	108	45	16
B	110	59	51	18-85	45	15,6	48	33	21	8

A: grupo para el cálculo de la dimensionalidad. B: grupo para el cálculo de la validez. T: total. H: hombres. M: mujeres. R: rango de edad. M: media. dt: desviación típica. ct: ceguera total. cp: ceguera parcial. dvs: deficiencia visual severa. dvm: deficiencia visual moderada.

En ambos grupos se observa el predominio de personas con ceguera total (sin percepción de luz o cuya escasa percepción no les es útil para orientarse o moverse) y con ceguera parcial (con percepción de luz, bultos o colores que les ayudan a orientarse o moverse). Por otra parte, existe un subgrupo menor de personas con deficiencia visual severa (que requieren ayudas ópticas para percibir objetos y caracteres impresos) y uno muy reducido con deficiencia visual moderada (que no precisan de ayudas específicas).

El rango de edad es amplio en ambos grupos, de lo que resultan unas medias muy similares.

Tabla 5b. Características de los grupos normativos

	< 6	6-12	12-18	18-24	24-36	36-48	> 48	nat
A	35	57	17	47	37	26	136	2
B	15	21	4	15	11	4	32	8

Las cifras de la fila superior indican los meses transcurridos desde la pérdida de visión hasta la administración de la prueba. nat: déficit congénito. Las de las filas inferiores muestran el número de personas que se hallan en cada condición.

El tiempo transcurrido entre el momento en que las personas evaluadas habían perdido la vista y la administración de la prueba se distribuye en un amplio abanico. Así, se evaluaron desde personas con una pérdida muy reciente hasta otras con ceguera congénita. En todos los casos se verificó la capacidad discriminadora del CTAC.

Al recoger este dato, perdía certeza la cifra indicada en el grupo de cuatro o más años, ya que podía existir confusión entre el momento de inicio de los problemas visuales, no siempre lo suficientemente limitadores como para convertirse en una fuente importante de estrés, y el de una pérdida mayor, que, por otra parte, es difícil situar cronológicamente en aquellos casos en que ha sido progresiva. En el grupo B, 83 personas habían perdido la vista progresivamente y 27 de forma brusca.

Todas las personas se evaluaban para participar en un programa de rehabilitación. La discrepancia entre el total de la muestra y la suma de los descriptores se debe a la pérdida de datos en la compleja recogida de la información.

Normas para la administración y corrección del cuestionario

Material

La prueba está concebida para ser leída por el psicólogo administrador; sin embargo, no se excluye la posibilidad de que pueda ser autoadministrada (en formato impreso o en braille). Se considera que no deberían darse diferencias entre los tipos de administración, si bien este extremo debería verificarse experimentalmente. El cuestionario (apéndice 3) incluye un único listado con los 35 ítems de las dos escalas mezclados, y el registro de respuestas a renglón seguido de cada ítem, lo que facilita el posterior análisis cualitativo de las respuestas. Figura también el formato de consigna que se aconseja utilizar. En el apéndice 2 de este manual se incluyen la consigna y las tablas de corrección.

El cuestionario está editado también en braille, para su uso por psicólogos con ceguera que prefieran utilizar este código de lectoescritura. Existe una versión en catalán que responde, según la observación incidental realizada en la administración de un centenar de cuestionarios en ese idioma, a los mismos patrones que la española.

Instrucciones para el administrador

Las condiciones de administración de esta prueba son las habituales de otros cuestionarios de los llamados *de lápiz y papel*, si bien, en este caso, hay que tener en cuenta la especificidad del déficit visual. Se puede consultar una guía para la evaluación de personas con este déficit en Pelechano, Peñate y De Miguel (1995) y, especialmente, en Checa, Díaz y Pallero (2003).

Al tratarse de una prueba cuyo principal modo de administración es la lectura por parte del psicólogo, se deberá procurar que el tono de voz empleado y la actitud del evaluador

no indiquen una tendencia de respuesta. En este sentido, es aconsejable explicar a la persona evaluada que no hay respuestas correctas ni incorrectas, y que el objetivo de la prueba es ofrecerle una atención, tanto por parte del psicólogo como de cualquier otro técnico, adecuada a su estado.

Una vez establecidas las condiciones adecuadas para la administración del CTAC, como en cualquier test psicológico, se indicará a la persona evaluada que se le van a leer una serie de frases que tienen que ver con su déficit visual y en las que se explican diversas situaciones en las que se puede encontrar. Hay que insistirle en que se le explicarán una serie de escenas que deberá imaginar tal como las viviría en el caso de que le sucedieran en el momento actual y con sus habilidades actuales, y que, una vez las haya imaginado, deberá responder sobre la reacción que se le proponga. Hay que intentar conducir a la persona hacia la reacción concreta, en especial cuando el ítem provoca que nos relate algún hecho relacionado con la situación evocada. En algunos casos (dependerá del nivel cultural y de la situación emocional en que se encuentre) se deberá recordar la necesidad de imaginar la situación desde el estado actual. La experiencia de las administraciones previas indica, contrariamente a las instrucciones de las fases experimentales, que en ocasiones hay que explicar la escena de forma coloquial, después de haber leído el ítem. A modo de ejemplo, el ítem 2(C2):

Imagínese que, estando en casa de unos amigos, con muchos objetos de decoración, necesita ir al baño. ¿En qué medida le cuesta decidirse?

puede ampliarse diciendo: «mesillas con fotografías, algunas macetas, jarrones en el aparador, etc.; cosas que, al pasar, incluso viendo, parece que se van a tirar, por lo que hace que se lo piense dos veces antes de ir». Estas explicaciones, si bien hacen que las administraciones pierdan uniformidad, nos permitirán asegurarnos de que la persona responde a nuestro planteamiento y no a cualquier otra cosa (en el apéndice 1 se puede ver un listado de sugerencias de comentarios aclaratorios para hacer a la persona evaluada).

Para la respuesta, se propone una escala de Likert con cinco puntos:

1. Muy poco.
2. Un poco.
3. A medias.
4. Bastante.
5. Mucho.

El uno y el cinco corresponden a la mínima y máxima intensidad de sensación, respectivamente. Es recomendable sugerir a la persona evaluada que imagine un termómetro en el que *abajo está el uno y arriba el cinco* y que la intensidad de la sensación es *la temperatura que sube*. La imagen gráfica del termómetro es comprensible incluso para personas con ceguera congénita.

Sugerencia de presentación:

A continuación le voy a leer unas frases. Casi todas comienzan con un «Imagínese...», al que sigue una situación que tiene que ver con su situación visual. Es posible que muchas de esas situaciones no las haya vivido todavía. Le pido que haga un esfuerzo de imaginación, incluso en aquellas en que le parezca imposible llegar a estar. Si ya las ha vivido, imagínese que las vive de nuevo.

Después de imaginar la situación, le pediré que explique cómo cree que reaccionaría. Su respuesta deberá indicar cómo cree que reaccionaría en el caso de vivirlas AHORA, en el MOMENTO ACTUAL. Para responder, utilice los números del 1 al 5, siendo:

1. Muy poco.
2. Un poco.
3. A medias.
4. Bastante.
5. Mucho.

Una manera de hacerlo es que se imagine un termómetro, en el que el 1 sea lo más bajo y el 5 lo más alto, y que imagine que la intensidad de la sensación es la subida de la temperatura. Usted me tendrá que dar el número que corresponda.

Ahora le voy a poner un ejemplo en el que tiene poco que imaginar:

«Imagínese que le están haciendo un test sobre su situación actual. ¿En qué medida se siente alterado?».

Es importante insistir en que se ha de responder dando una cifra concreta.

Puntuación y corrección

Las contestaciones se van anotando en la hoja de respuestas. La cifra indicada por el sujeto evaluado (1, 2, 3, 4 ó 5) se especifica en la columna correspondiente a la escala del ítem: columna derecha para los ítems de ansiedad fisiológica (F) y columna izquierda para los ítems de ansiedad cognoscitiva (C).

Para la corrección de la prueba, se procederá a la suma de las columnas por separado. La puntuación obtenida en cada una de ellas se anotará en la casilla correspondiente, que figura en la última página de la hoja de respuestas con la siguiente indicación: *puntuaciones directas escala cognoscitiva (C)* y *escala fisiológica (F)*. La suma de ambas, por otra parte, se anotará en la casilla *puntuaciones directas escala total C + F*. Al pie de las columnas de cada hoja, se ha dejado un espacio para las sumas parciales, con el propósito de facilitar el recuento.

Las puntuaciones obtenidas permitirán la obtención de las puntuaciones centiles (tabla 7) y las puntuaciones T (tablas 8 y 10).

Uso de las tablas normativas

En general, las puntuaciones directas no tienen una interpretación inmediata, por lo que es necesario transformarlas en una nueva escala que proporcione información sobre la posición relativa del sujeto con relación a

un grupo normativo. Las tablas que se incluyen en el apéndice 2 permiten la estimación de los centiles a partir de las puntuaciones directas en las tres escalas. Así mismo, permiten obtener la correspondencia entre las puntuaciones directas y las puntuaciones en la escala T (media 50 y desviación típica 10). Las tablas incluidas son las siguientes:

- Tabla 6. Estimación de centiles para las puntuaciones directas de las escalas *ansiedad cognoscitiva* (C), *ansiedad fisiológica* (F) y *ansiedad total*.
Permite obtener los centiles correspondientes a las puntuaciones directas en cualquiera de las tres escalas. Los centiles se deben interpretar como el porcentaje de sujetos del grupo normativo que ha obtenido una puntuación directa igual o inferior a la consultada. En el cuerpo de la tabla figuran las puntuaciones directas, y en las columnas de los extremos los centiles correspondientes. A pie de tabla se incluyen las medias y desviaciones típicas, así como el tamaño de la muestra. Estos centiles se han calculado a partir de la muestra total de 352 participantes.
- Tabla 7. Estimación de centiles normalizados para las puntuaciones directas de las escalas *ansiedad cognoscitiva* (C), *ansiedad fisiológica* (F) y *ansiedad total*.
Permite obtener los centiles normalizados correspondientes a las puntuaciones directas de cualquiera de las tres escalas. Los centiles normalizados se deben interpretar como el porcentaje de sujetos de la población general estudiada (de la que el grupo normativo es una muestra) que obtendría una puntuación directa igual o inferior a la consultada. Estos percentiles normalizados se calculan a partir de las áreas bajo la curva normal y, por tanto, se basan en el supuesto de que la distribución de las puntuaciones en la población es aproximadamente normal. En el cuerpo de la tabla figuran las puntuaciones directas, y en las columnas de los extremos los centiles normalizados correspondientes.

- Tabla 8. Conversión de puntuaciones directas a puntuaciones T para las tres escalas.
Permite convertir las puntuaciones directas a escala T. En el cuerpo de la tabla figuran las puntuaciones directas, y en las columnas de los extremos las puntuaciones en escala T. El uso de este tipo de escalas se justifica por el hecho de que las escalas psicométricas se interpretan tomando como origen la media y como unidad la d. t. Si se usan las puntuaciones directas, en la escala resultante se obtienen valores negativos y valores decimales, por lo que no resulta cómoda de interpretar. Para evitar este inconveniente, las puntuaciones se transforman a una escala de fácil manejo. La escala T (escala de Terman-Thourstone), con media 50 y dt 10, es una de las transformaciones más comunes en personalidad y, además, resulta de muy fácil interpretación. Así, p. ej., si un sujeto tiene una puntuación $T = 70$, sabemos de inmediato que se sitúa dos desviaciones típicas por encima de la media.
- Tabla 9. Estimación de centiles para las puntuaciones T de las escalas *ansiedad cognoscitiva* (C), *ansiedad fisiológica* (F) y *ansiedad total*.
Esta tabla es similar a la tabla 6, pero se basa en puntuaciones T. En el cuerpo de la tabla figuran las puntuaciones T, y en las columnas de los extremos los centiles correspondientes, que se han calculado a partir de la muestra de 352 participantes.
- Tabla 10. Estimación de centiles normalizados para las puntuaciones T de las escalas *ansiedad cognoscitiva* (C), *ansiedad fisiológica* (F) y *ansiedad total*.
Esta tabla es similar a la tabla 7, pero se basa en puntuaciones T. En el cuerpo de la tabla figuran las puntuaciones T, y en las columnas de los extremos los centiles normalizados correspondientes.

Se aconseja utilizar la tabla 7 (centiles normalizados) antes que la 6 (centiles sin normalizar), y la 10 (centiles normalizados) antes que la 9 (centiles sin normalizar), pues las primeras permiten interpretar los centiles en ellas obtenidos con relación a la población general objeto del CTAC, mientras que las segundas lo hacen respecto al grupo normativo.

Referencias bibliográficas

- Amelang, M.; Bartussek, D. (1986). *Psicología diferencial e investigación en personalidad*. Barcelona: Herder.
- Bauman, M. K. (1963). *Characteristics of blind and visually handicapped people in professional, sales and managerial work*. Harrisburg: Pennsylvania Office for the Blind.
- Bauman, M. K.; Yoder, N. M. (1966). *Adjustment to blindness, re-viewed*. Springfield: Charles C. Thomas.
- Bayés, R. (2001). *Psicología del sufrimiento y de la muerte*. Barcelona: Martínez Roca.
- Checa, J.; Díaz, P.; Pallero, R. (coords.) (2003). *Psicología y ceguera. Manual para la intervención psicológica en el ajuste a la deficiencia visual*. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
- Dodds, A. G.; Bailey, P.; Pearson, A.; Yates, L. (1991). Psychological Factors in Acquired Visual Impairment: The Development of a Scale of Adjustment, *Journal of Visual Impairment and Blindness* 85, 306-310.
- Dodds, A. G.; Craig, D.; Flannigan, H. (1996). The Nottingham Adjustment Scale: An Estimation of Response Bias, *Journal of Visual Impairment and Blindness* 90, 51-57.
- Dodds, A. G.; Flannigan, H.; Ng, L. (1993). The Nottingham Adjustmen Scale: a validation study, *International Journal of Rehabilitation Research* 16, 177-184.
- Eysenck, M. W. (1985). *Atención y activación. Cognición y realización*. Barcelona: Herder.
- Ferrando, P. J.; Pallero, R. (1994). Construcción de una escala de ansiedad-estado: prevención del fracaso en rehabilitación/habilitación de personas ciegas y deficientes visuales. En: *Actas del Congreso Estatal sobre Prestación de Servicios para Personas Ciegas y Deficientes Visuales*, vol. 1. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
- Ferrando, P. J.; Pallero, R.; Lorenzo, U. (1996). Elaboración y estudio de fiabilidad de una escala de ansiedad para personas con discapacidad visual, *Integración* 20, 5-10.

- Fitting, E. A. (1954). *Evaluation of adjustment to blindness*. Nueva York: American Foundation for the Blind.
- Hardy, R. E. (1968). *The anxiety scale for the blind*. Nueva York: American Foundation for the Blind.
- Kef, S. (1999). *Outlook on Relations. Personal Networks and Psychosocial Characteristics of Visually Impaired Adolescents*. Tesis doctoral, Universidad de Amsterdam (Países Bajos).
- Lazarus, R. S. (2000). *Estrés y emoción. Manejo e implicaciones en nuestra salud*. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Leonhardt, M. (1992). *Escala Leonhardt. Escala de desarrollo de niños ciegos de 0 a 2 años*. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
- Liebert, R. M.; Morris, L. W. (1967). Cognitive and emotional components of test anxiety: A distinction and some initial data, *Psychological Reports* 20, 975-978.
- McBroom, L. W.; Shindell, S.; Elston R. R. (1997). Vocational and psychological assessments. En: Moore, J. E.; Graves, W. H.; Patterson, J. B. (eds.). *Foundations of rehabilitation counselling with persons who are blind or visually impaired*. Nueva York: AFB Press.
- Miguel Tobal, J. J.; Cano Vindel, A. R. (1997). *ISRA. Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad*. Madrid: TEA.
- Pallero, R. (2001). *Adaptación española de la escala Nottingham Adjustment Scale-NAS de Allan G. Dodds*. Trabajo experimental de programa de doctorado, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona. No publicado.
- Pallero, R.; Ferrando, P. J.; Díaz, M.; Lorenzo, U. (2002). Adaptación española de la Escala de Ajuste de Nottingham. I. Estudio de fiabilidad, *Integración* 40, 7-20.
- Pallero, R.; Ferrando, P. J.; Lorenzo, U. (1998). Questionnaire Tarragona of anxiety for blind People. En: Sifferman, E.; Williams, M.; Blasch, B. B. (eds.). *The 9th International Mobility Conference. O & M Moving into the Twenty-First Century*. Atlanta: Rehabilitation Research & Development Center.
- Pallero, R.; Ferrando, P. J.; Lorenzo, U. (1999). Cuestionario Tarragona de ansiedad para ciegos. En: Verdugo, M. A.; Jordán de Urries, F. de B. *Hacia una nueva concepción de la discapacidad*. Salamanca: Amarú.

- Pelechano, V.; Peñate, W.; De Miguel, A. (1995). Evaluación y tratamiento en las deficiencias visuales. En: Verdugo, M. A. (dir.). *Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras*. Madrid: Siglo XXI.
- Spielberger, C. D. (1972). *Current trends in theory and research*. Nueva York: Academic Press.
- Spielberger, C. D.; Gorsuch, R. L.; Lushene, R. E. (1982). *Cuestionario de ansiedad estado-rasgo, STAI*. Madrid: TEA.
- Taylor, J. A. (1953). A personality scale of manifest anxiety, *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 45, 285-290.
- Tobin, M. (1994). *Assessing visually handicapped people. An introduction to tests procedures*. Londres: David Fulton.
- Welsh, R. L. (1997). The psychosocial dimensions of orientation and mobility. En: Blasch, B. B.; Wiener, W. R.; Welsh, R. L. (eds.). *Foundations of orientation and mobility*. Nueva York: AFB Press.

Apéndices

Apéndice 1

Comentarios aclaratorios de los ítems

1. *Está en la cocina preparándose un vaso de leche o tomando una medicina y se le cae una cucharilla al suelo. Intenta localizarla con la mano o con el pie y no aparece.*
2. *Vd. ya sabe que hay mesillas con fotografías, algunas macetas, jarrones en el aparador... cosas que, al pasar, incluso viendo, parece que se van a tirar, por lo que ha de pensárselo dos veces antes de ir.*
3. *De antes de perder la vista, con los que no ha contactado desde entonces.*
4. *Si la persona ya es capaz de hacerlo, ante la respuesta «Sí, ya he aprendido; no sentiré nada», hay que insistir en que se imagine viviéndolo en ese instante.*
5. *No parece necesaria explicación alguna.*
6. *Está buscando una concreta, y no sabe con claridad cuál es cuál.*
7. *Al no poder comprobar si lleva alguna mancha, si lleva los botones abrochados, si va mal conjuntado...*
8. *Al no verlo o no verlo bien, poder darle un golpe y que se caiga.*
9. *Ante la posible pregunta sobre qué tipo de problema, hay que indicarle: el visual.*
10. *Yendo con la persona que enseña el bastón y a moverse por la calle, se hace un lío con las pistas que ayudan a saber por dónde se va y dónde se está.*
11. *No parece necesaria explicación alguna.*
12. *No parece necesaria explicación alguna.*
13. *De alivio al llegar a casa y estar seguro.*
14. *Los niños y las niñas que corren y juegan por la calle le hacen temer un golpe o desorientarse.*
15. *Ir a un sitio al que no ha ido nunca, pero al que le han indicado cómo ir.*
16. *Algo de la cocina, algo de aseo, algo de manualidades..., cualquier cosa que esté haciendo y que le dicen que tiene un pequeño fallo.*

17. No parece necesaria explicación alguna.
18. *Algo de la cocina, cualquier tarea doméstica, algo del taller de manualidades...*
19. No parece necesaria explicación alguna.
20. *Cualquier cosa nueva se le olvida de lo nervioso/a que se encuentra.*
21. *Va solo/a por la calle y tiene que pedir a alguien que le oriente, que le lea la placa de una calle o le indique un número.*
22. *Entra Vd. en una tienda o en una cafetería, con el bastón o con alguien que le acompaña, y al darse cuenta de que es el centro de atención, querría que se lo tragara la tierra.*
23. *Le ayudan a cruzar, sin preguntarle ni siquiera si necesita ayuda.*
24. No parece necesaria explicación alguna.
25. No parece necesaria explicación alguna.
26. *Pensando en las reacciones que tendrá la gente ante su déficit.*
27. La diferencia respecto a la 9(C7) está en el *constantemente. Repetir el visual.*
28. *Al no poder comprobar si está apagada o no.*
29. *Por tener que ir con temor, incluso por casa.*
30. *Lo inesperado le hace caminar más despacio.*
31. *Debe ser Vd. quien dirija su camino.*
32. *Que no puede decidir dónde ir, sin depender de otros.*
33. No parece necesaria explicación alguna.
34. No parece necesaria explicación alguna.
35. *Los nervios le hacen sudar.*

Apéndice 2
Tablas normativas

Tabla 6. Estimación de centiles para las puntuaciones directas de las escalas *Ansiedad cognoscitiva*, *fisiológica* y *total*

Centil	Puntuación directa			Centil
	Ansiedad cognoscitiva	Ansiedad fisiológica	Ansiedad total	
99	90-100	75	163-175	99
95	82	67	144	95
90	73	65	134	90
85	69	62	128	85
80	65	60	123	80
75	63	58	119	75
70	60	57	115	70
65	58	54	110	65
60	55	52	107	60
55	53	50	103	55
50	49	48	100	50
45	48	47	95	45
40	46	45	91	40
35	43	43	87	35
30	41	41	82	30
25	39	38	80	25
20	36	36	76	20
15	34	34	71	15
10	31	30	64	10
5	29	27	57	5
1	20	15	35	1

Media	51,45	47,95	99,40	Media
Desviación típica	15,75	12,85	26,48	Desviación típica
N	352	352	352	N

**Tabla 7. Estimación de centiles normalizados
para las puntuaciones directas de las escalas
*Ansiedad cognoscitiva, fisiológica y total***

Centil	Puntuación directa			Centil
	Ansiedad cognoscitiva	Ansiedad fisiológica	Ansiedad total	
99	88-100	75	157-175	99
95	76	69	141	95
90	70	63	133	90
85	66	61	125	85
80	64	57	121	80
75	62	55	117	75
70	58	53	113	70
65	56	51	109	65
60	54	—	105	60
55	52	49	101	55
50	50	47	99	50
45	48	45	95	45
40	46	—	91	40
35	44	43	89	35
30	42	41	85	30
25	40	39	81	25
20	38	37	77	20
15	34	33	71	15
10	30	31	65	10
5	24	25	55	5
1	20	15-19	35-41	1

Tabla 8. Conversión de puntuaciones directas a puntuaciones T para las tres escalas

Escala T	Puntuación directa			Escala T
	Ansiedad cognoscitiva	Ansiedad fisiológica	Ansiedad total	
80	99-100			80
79	97-98		175	79
78	96		173-174	78
77	94-95		170-172	77
76	93		167-169	76
75	91-92		165-166	75
74	89-90		162-164	74
73	88		159-161	73
72	86-87		157-158	72
71	85	75	154-156	71
70	83-84	73-74	151-153	70
69	81-82	72	149-150	69
68	80	71	146-148	68
67	78-79	70	144-145	67
66	77	68-69	141-143	66
65	75-76	67	138-140	65
64	73-74	66	136-137	64
63	72	64-65	133-135	63
62	70-71	63	130-132	62
61	69	62	128-129	61
60	67-68	61	125-127	60
59	66	59-60	122-124	59
58	64-65	58	120-121	58
57	62-63	57	117-119	57
56	61	56	114-116	56
55	59-60	54-55	112-113	55
54	58	53	109-111	54
53	56-57	52	107-108	53
52	54-55	50-51	104-106	52
51	53	49	101-103	51
50	51-52	48	99-100	50
49	50	47	96-98	49
48	48-49	45-46	93-95	48
47	46-47	44	91-92	47
46	45	43	88-90	46
45	43-44	41-42	85-87	45
44	42	40	83-84	44

Tabla 8. Conversión de puntuaciones directas a puntuaciones T para las tres escalas *(Continuación)*

Escala T	Puntuación directa			Escala T
	Ansiedad cognoscitiva	Ansiedad fisiológica	Ansiedad total	
43	40-41	39	80-82	43
42	38-39	38	77-79	42
41	37	36-37	75-76	41
40	35-36	35	72-74	40
39	34	34	69-71	39
38	32-33	32-33	67-68	38
37	30-31	31	64-66	37
36	29	30	62-63	36
35	27-28	29	59-61	35
34	26	27-28	56-58	34
33	24-25	26	54-55	33
32	22-23	25	51-53	32
31	21	23-24	48-50	31
30	20	22	46-47	30
29		21	43-45	29
28		20	40-42	28
27		18-19	38-39	27
26		17	35-37	26
25		16		25
24		15		24

Tabla 9. Estimación de centiles para las puntuaciones T de las escalas *Ansiedad cognoscitiva*, *fisiológica* y *total*

Centil	Puntuación directa			Centil
	Ansiedad cognoscitiva	Ansiedad fisiológica	Ansiedad total	
99	74–81	71	74–79	99
95	69	65	67	95
90	63	63	63	90
85	61	61	61	85
80	59	60	59	80
75	57	58	57	75
70	55	57	56	70
65	54	55	54	65
60	52	53	53	60
55	51	52	51	55
50	48	50	50	50
45	—	49	48	45
40	47	48	47	40
35	45	46	45	35
30	43	45	43	30
25	42	42	—	25
20	41	41	41	20
15	39	39	39	15
10	37	36	37	10
5	36	34	34	5
1	30	26	27	1

Media	50	50	50	Media
Desviación típica	10	10	10	Desviación típica

Tabla 10. Estimación de centiles normalizados para las puntuaciones T de las escalas *Ansiedad cognoscitiva*, *fisiológica* y *total*

Centil normalizado	Escala T			Centil normalizado
	Ansiedad cognoscitiva	Ansiedad fisiológica	Ansiedad total	
99	73-81	71	72-79	99
95	65	66	66	95
90	62	62	63	90
85	59	60	60	85
80	58	57	58	80
75	57	55	57	75
70	54	54	55	70
65	53	52	54	65
60	52	—	52	60
55	50	51	51	55
50	49	49	50	50
45	48	48	48	45
40	47	—	47	40
35	45	46	46	35
30	44	45	45	30
25	43	43	43	25
20	42	41	42	20
15	39	38	39	15
10	37	37	37	10
5	33	32	33	5
1	30	24-27	25-28	1

Apéndice 3

Cuestionario Tarragona de ansiedad para ciegos (CTAC)

Autores:

Rafael Pallero González, ONCE

Pere Joan Ferrando Piera y Urbano Lorenzo Seva, Universidad Rovira i Virgili

El desarrollo de este cuestionario ha sido financiado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

Nombre y apellidos:

Edad: **Sexo:** **Estado civil:**

Fecha de administración:

Consigna:

A continuación le voy a leer unas frases. Casi todas comienzan con un «Imagínese...» y continúan después con un supuesto que tiene que ver con su situación visual. Es posible que muchas de esas experiencias no las haya vivido todavía. Le pido que haga un esfuerzo de imaginación, incluso en aquellas que le parezca imposible llegar a estar. Si ya las ha vivido, imagínese que las vive de nuevo. Después de la situación le pediré que diga cómo cree que reaccionaría. Su respuesta deberá indicar cómo cree que reaccionaría de vivirlas AHORA, en el MOMENTO ACTUAL. Para responder utilice los números del 1 al 5. Siendo:

1. Muy poco.
2. Un poco.
3. A medias.
4. Bastante.
5. Mucho.

Una manera de hacerlo es que se imagine un termómetro, en el que el 1 sea lo más bajo y el 5 lo más alto, y se imagine que la intensidad de la sensación es la subida de la temperatura. Usted me tendrá que decir el número que corresponda.

Ahora le voy a poner un ejemplo en el que tiene poco que imaginar:

«Imagínese que le están haciendo un test sobre su situación actual,

¿En que medida se siente alterado?»

1 2 3 4 5

Es importante que se insista en que hay que responder dando un número.

1(C1). Imagínese que estando solo/a en casa se le cae una cuchara al suelo y no la encuentra. ¿En qué medida se siente impotente?	1 2 3 4 5	
2(C2). Imagínese que estando en casa de unos amigos, con muchos objetos de decoración, necesita ir al baño. ¿En qué medida le cuesta decidirse?	1 2 3 4 5	
3(C3). Imagínese que le invitan a una reunión de antiguos compañeros/as. ¿En qué medida se preocupa pensando en las reacciones que tendrán?	1 2 3 4 5	
4(F1). Imagínase que realiza, solo/a, un trayecto a pie nuevo para Vd. ¿En qué medida cree que llegará sudoroso/a (por los nervios) al final del mismo?		1 2 3 4 5
5(F2). Imagínese la primera vez que sale a la calle sin guía. ¿En qué medida siente latir su corazón?		1 2 3 4 5
6(C4). Imagínese que al vestirse no distingue entre dos camisas/blusas. ¿En qué medida se siente impotente?	1 2 3 4 5	
7(C5). Imagínese que le presentan a alguien importante para Vd. ¿En qué medida le preocupa su propio aspecto?	1 2 3 4 5	
8(C6). Imagínese que va a tocar una jarra. ¿En qué medida siente que la puede romper?	1 2 3 4 5	
9(C7). ¿En qué medida piensa en su problema?	1 2 3 4 5	
10(F3). Imagínese que hace un itinerario con ayuda del profesor de movilidad y se complican las pistas para orientarse. ¿En qué medida se le acelera el corazón?		1 2 3 4 5
11(F4). ¿En qué medida los ruidos inesperados le dejan sin respiración?		1 2 3 4 5
12(F5). Imagínese el primer recorrido con el bastón blanco. ¿En qué medida se siente tenso/a?		1 2 3 4 5
13(F6). Imagínese que regresa a casa después de un itinerario. ¿En qué medida siente que vuelve a respirar?		1 2 3 4 5

14(F7). Imagínese que yendo solo/a por la calle se siente rodeado/a por un grupo de niños y niñas que pasan. ¿En qué medida siente que le tiemblan las piernas?		1 2 3 4 5
15(F8). Imagínese que al día siguiente tiene que hacer, solo/a, un trayecto nuevo. ¿En qué medida duerme mal esa noche?		1 2 3 4 5
16(C8). Imagínese que, realizando una actividad, le hacen una pequeña crítica. ¿En qué medida siente ganas de llorar?	1 2 3 4 5	
17(C9). Imagínese que, realizando una actividad, se le hace tarde para acabarla. ¿En qué medida se siente desbordado/a?	1 2 3 4 5	
18(C10). Imagínese que va a realizar una tarea complicada. ¿En qué medida piensa que le va a salir mal?	1 2 3 4 5	
19(F9). Imagínese que yendo solo/a por la calle, bruscamente pita un camión. ¿En qué medida se le encoge el estómago?		1 2 3 4 5
20(C11). ¿En qué medida los nervios le hacen olvidar hasta lo más sencillo que aprende?	1 2 3 4 5	
21(C12). Imagínese que tiene que dirigirse a una persona desconocida para preguntar una dirección. ¿En qué medida se siente cohibido/a?	1 2 3 4 5	
22(C13). Imagínese que al entrar en un lugar público siente que se hace un momento de silencio (por Vd.). ¿En qué medida quisiera pasar desapercibido/a?	1 2 3 4 5	
23(C14). Imagínese que al ir a cruzar la calle, alguien le toma del brazo sin consultarle. ¿En qué medida se siente ofendido/a?	1 2 3 4 5	
24(F10). Imagínese que tiene que realizar solo/a, un itinerario tomando un autobús. ¿En qué medida siente un estado de agitación?		1 2 3 4 5
25(C15). Imagínese que al ir a pagar en una tienda, el dependiente le quita las monedas de las manos para contarlas. ¿En qué medida se siente infravalorado/a?	1 2 3 4 5	

26(C16). Imagínese que le invitan a una fiesta. ¿En qué medida se siente agobiado/a?	1 2 3 4 5	
27(C17). ¿En qué medida piensa constantemente en su problema?	1 2 3 4 5	
28(C18). Imagínese que sale de casa solo/a, a dar una vuelta. ¿En qué medida le preocupa haberse dejado alguna luz encendida?	1 2 3 4 5	
29(C19). Imagínese que alguien deja una silla en medio del comedor. ¿En qué medida siente que su hogar no es un sitio seguro?	1 2 3 4 5	
30(F11). Imagínese que, realizando solo/a un itinerario, oye un ruido inesperado. ¿En qué medida andará más despacio?		1 2 3 4 5
31(F12). Imagínese que, paseando, su acompañante va a otro lado y se despide de Vd., quedándose solo/a. ¿En qué medida se le acelera el corazón?		1 2 3 4 5
32(F13). ¿En qué medida siente que tiene poca autonomía para ir donde quiere?		1 2 3 4 5
33(F14). ¿En qué medida siente que, en su situación actual, lloraría con facilidad a poco que empeorasen las cosas?		1 2 3 4 5
34(C20). Imagínese que tiene que preguntar el número de un autobús. ¿En qué medida le irrita el tener que pedir ayuda?	1 2 3 4 5	
35(F15). Imagínese que realiza solo/a un trayecto a pie. ¿En qué medida cree que llegará sudoroso/a al final del mismo?		1 2 3 4 5

	Puntuaciones directas	Centiles	Puntuaciones T
Escala cognoscitiva (C)			
Escala fisiológica (F)			
Escala total (C + F)			

